摘要：
赛沃替尼联合奥希替尼的全球III期研究发表于《新英格兰医学杂志》，特定肺癌耐药患者死亡风险较化疗降低32%。另一项III期研究则将联合疗法推进至一线治疗。

10月26日，和黄医药公布赛沃替尼全球III期临床研究结果。与传统铂类双药化疗相比，其自主研发的赛沃替尼与阿斯利康已上市的第三代EGFR靶向药奥希替尼联合使用，将特定肺癌耐药患者的死亡风险相对降低32%，中位总生存期从12.9个月延长至17.8个月，增加近5个月。

这项研究结果已于10月25日在西班牙马德里举行的2026年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会主席论坛上公布，并同步发表于《新英格兰医学杂志》。

不过，这一治疗效果并不适用于所有肺癌患者。研究针对的是携带EGFR基因突变、在奥希替尼治疗后病情进展，同时伴有高水平MET过表达或扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

除了针对耐药患者的研究，和黄医药同期公布的另一项中国III期临床研究，还将赛沃替尼与奥希替尼的联合治疗推进至初始治疗阶段，为其后续拓展适应症及全球商业化提供了新的临床依据。

耐药治疗取得生存获益

肺癌靶向药耐药一直是晚期肺癌治疗面临的难题。

EGFR（表皮生长因子受体）和MET（间质上皮转化因子受体）都是与肿瘤生长有关的蛋白靶点。奥希替尼通过抑制EGFR信号通路发挥作用，但部分患者在用药一段时间后，癌细胞会通过MET信号通路继续生长，从而对原有治疗产生耐药。

赛沃替尼是一款针对MET靶点的口服抑制剂。将其与奥希替尼联合使用，目的在于同时抑制EGFR和MET两条信号通路，从而克服部分患者的耐药问题。

为验证这一治疗思路，研究者开展了代号为SAFFRON的全球III期临床研究。该研究采用随机、开放标签、多中心设计，覆盖29个国家的230个研究中心，共纳入338名奥希替尼治疗后病情进展、伴MET异常的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

其中，联合治疗组同时口服赛沃替尼和奥希替尼两种靶向药，对照组则接受铂类药物联合培美曲塞的传统化疗。

研究主要评价无进展生存期（PFS），即患者从研究规定的起点到疾病进展或死亡的时间；关键次要评价指标为总生存期（OS），即从研究规定的起点到患者死亡的时间。

数据显示，联合治疗组的中位OS为17.8个月，化疗组为12.9个月，延长4.9个月，死亡风险相对降低32%。治疗一年时，两组患者的生存率分别为70%和53%。

PFS方面，联合治疗组为7.6个月，化疗组为5.4个月，疾病进展或死亡风险相对降低45%。一年无进展生存率分别为36%和10%。

安全性方面，联合治疗组和化疗组发生3级及以上、所有原因导致的治疗期间不良事件的比例分别为64%和63%，未发现新的安全性信号。不过，联合治疗组发生严重不良事件的比例为

41%，高于化疗组的28%，仍需关注联合用药的安全性。

两种靶向药均可口服，能够减少静脉化疗带来的输液负担，但患者仍需定期复查并接受不良反应监测。

SAFFRON全球主要研究者、上海交通大学医学院附属胸科医院上海市肺部肿瘤临床医学中心主任陆舜表示，这些结果有望为约三分之一在奥希替尼治疗后出现MET驱动耐药的EGFR突变非小细胞肺癌患者确立新的全球治疗标准。

他同时强调，研究结果凸显了通过MET检测指导患者后续治疗的必要性。

联合疗法向一线治疗延伸

相比于耐药后的治疗，赛沃替尼的另一项III期研究SANOVO，尝试将联合用药提前至初始治疗阶段。

SANOVO是一项在中国开展的随机、双盲、多中心III期临床研究，针对此前尚未接受系统治疗、携带EGFR突变且伴MET过表达的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

与SAFFRON不同，这项研究的对照组并非传统化疗，而是单独使用奥希替尼，以检验从初始治疗阶段增加赛沃替尼，能否进一步改善患者预后。

结果显示，赛沃替尼联合奥希替尼组的中位PFS达到24.9个月，奥希替尼单药组为13.8个月，延长11.1个月，疾病进展或死亡风险相对降低44%。

在MET高表达患者中，联合治疗组的中位PFS为24.8个月，单药组为11.1个月，延长13.7个月。

OS方面，联合治疗组为44.5个月，对照组为34.9个月，相差9.6个月；三年生存率分别为67.4%和47.4%。

不过，和黄医药目前将SANOVO研究的OS结果描述为具有临床意义的改善，尚未明确披露其是否达到预设的统计学显著性标准。这与SAFFRON已证实具有统计学显著性的OS获益仍有区别。

两项研究共同指向赛沃替尼治疗定位的变化。

此前，赛沃替尼与奥希替尼的联合用药主要面向EGFR靶向药治疗后出现耐药的特定患者。而SANOVO尝试将其向一线治疗延伸，通过初始阶段的MET检测，筛选出可能从双靶向治疗中获益的患者。

这不仅意味着治疗时机提前，也可能扩大赛沃替尼的适用人群。从耐药后的部分患者，进一步覆盖初始治疗阶段伴MET过表达的人群，有望为赛沃替尼拓展新的市场空间。

但这一空间能否兑现，仍取决于后续适应症审批、临床应用及市场竞争情况。

全球商业化进入关键阶段

赛沃替尼由和黄医药自主发现和研发，并与阿斯利康共同开发，全球商业化由阿斯利康负责。

双方早在2011年便达成赛沃替尼的全球许可、共同开发及商业化合作协议。按照相关安排，阿斯利康负责中国以外地区的主要临床开发及商业化工作，和黄医药则可通过里程碑付款及销售

分成分享产品收益。

根据和黄医药年报，赛沃替尼若在中国以外市场实现商业化，公司有权获得相关销售额9%至13%的分级特许权使用费，并根据约定取得相应的里程碑付款。

这也意味着，赛沃替尼的海外上市进展，不仅关系到药物的国际市场覆盖，还将影响和黄医药未来的授权合作收益。

目前，赛沃替尼与奥希替尼联合方案已于2025年6月在中国获批，用于EGFR靶向药治疗后病情进展、伴MET扩增的部分局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌患者。

但已获批的患者范围与SAFFRON研究并不完全相同。前者要求MET扩增，而SAFFRON还纳入了符合标准的MET高水平过表达患者。

海外方面，针对耐药患者的联合疗法上市申请已经提交美国食品药品监督管理局（FDA），欧洲和日本的申报工作也在推进。

在一线治疗方面，和黄医药计划基于SANOVO研究结果，于2026年底在中国提交新的适应症上市申请。

此前，和黄医药另一款自主研发的抗癌药呋喹替尼，已经先后在美国、欧盟和日本获批上市，并由武田制药负责中国以外市场的商业化。

如果赛沃替尼后续顺利获得美国、欧盟和日本市场批准，将成为和黄医药继呋喹替尼之后，又一款进入全球主要医药市场的原创新药。

不过，临床研究成功并不意味着商业价值已经兑现。

赛沃替尼仍需跨过海外监管审评、市场准入和商业推广等环节，其未来销售规模还将受到目标患者数量、MET检测普及程度、其他耐药治疗方案竞争以及药品定价等因素的影响。

对于和黄医药而言，这两项III期研究的意义，是为赛沃替尼提供了进一步进入全球市场、并从耐药治疗向一线治疗拓展的临床依据。接下来，如何将研究中的生存获益转化为实际获批适应症和商业收入，将成为检验其全球化价值的关键。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

22 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论